



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Павлова академіка, 48, тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcrl@i.ua
КОД ЄДРПОУ 01996272

08.08.23 № 843/04

Начальнику

Відділу врегулювання страхових випадків

Приватного Акціонерного Підприємства «МетЛайф»

Андрію НАСОНУ

Адміністрація КНП «Золочівська ЦРЛ» на Ваш запит від 01.08.2023 № 738-ОЛ повідомляє, що СВИДЕРСЬКИЙ Василь Петрович, 20.09.1966 року народження, житель с. Бужок, Золочівського району Львівської області знаходився на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні КНП «Золочівська ЦРЛ» з 03.07.2023 по 11.07.2023. Діагноз: S86.0-Травматичний розрив правого ахілового сухожилка (з накладенням гіпсової пов'язки) (медична карта стаціонарного хворого № 3238).

Епікриз виписний 3238 додається.

Директор

КНП «Золочівська ЦРЛ»



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

УКРАЇНА ГОСУДАРСТВЕННЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ Міністерство охорони здоров'я України ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 01996272 КНП "Золочівська ЦРЛ" № 2 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. Ак. Павлова, 48 <i>80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Павлова академіка, 48. Тел.: 4-21-36</i>	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма первинної облікової документації № 003/о ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 21.01.2016 № 29
--	--

45. ЕПІКРИЗ ВИПИСНИЙ 3238

Відділення:	Хірургічне відділення № 1		
П.І.Б. хворого:	Свідерський Василь Петрович	Дата народж.:	20.09.1966
Адреса:	11, село БУЖОК, ЛЬВІВСЬКА область	Вік:	56 років
Госпіталізація	03.07.2023 Час: 16:50	Дата виписки:	11.07.2023 Час: 14:00

СКАРГИ:

на болі, набряк в ділянці правого ахіллового сухожилля, порушення функції правої н / кінцівки.

АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ:

Зі слів пацієнта : травма побутова, підвернув ногу на вулиці. В анамнезі введення гормональних препаратів в ділянку ахіллового сухожилля, 4 процедури за 4 місяці. Відмічав біль в ділянці останнього. За першою мед. допомогою звернулася в травмпункт. Був оглянутий травматологом, рекомендовано оперативне лікування. Госпіталізований в хірургічне відділення для подальшого оперативного лікування.

ЗАГАЛЬНИЙ АНАМНЕЗ:

зі слів пацієнта: цукровий діабет, вірусний гепатит, туберкульоз, венеричні захворювання заперечує. Алергологічний анамнез не обтяжений. Зловживання алкоголем, вживання наркотичних речовин, куріння - заперечує. Компоненти і препарати крові раніше не переливались.

СТРАХОВИЙ АНАМНЕЗ:

На листку непрацездатності за останні 12 міс. не знаходився, не працює, інвалід 3 гр.

ОБ'ЄКТИВНИЙ СТАТУС:

при госпіталізації:

загальний стан середнього ступеня важкості. Статура нормостенічного типу. \Свідомість ясна. Шкірні покриви і видимі слизові - бліді. Дихання везикулярне. Хрипів немає. ЧД - 16 в хв. Пульс 76 уд. в хв., ритмічний. АТ 130/80 мм.рт.ст. ЧСС - 76 в хв. Живіт м'який, безболісний, бере участь в акті дихання. с-ми подразнення очеревини не визначаються, С-м Пастернацького негативний з обох сторін. Стіл і діурез в нормі, без особливостей.

при виписці:

Динаміка задовільна. Загальний стан пацієнта задовільний.

ЛОКАЛЬНИЙ СТАТУС:

при госпіталізації:

При огляді в ділянці правого г / стопного суглоба - набряк в проекції ахіллового сухожилля. При пальпації - біль в ділянці дефекту сухожилля, западіння м'яких тканин. Відзначається зниження активного підошовного згинання в правій стопі. Неможливість встати на пальці травмованої кінцівки. Чутливість і пульсація периферичних артерій травмованої кінцівки збережена. Пальці стопи теплі, рухливі.

при виписці:

В динаміці стан пацієнта покращився. Пересувається за допомогою милиць, без навантаження на праву н/кінцівку. Імобілізація правої н/кінцівки задовільна. Рани гояться первинно, без ознак запалення. Ангіоневротичних розладів не виявлено.

Дані обстеження:

Результати аналізів: Група крові

Міністерство охорони здоров'я України КНП "Золочівська ЦРЛ" 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. Ак. Павлова, 48	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма первинної облікової документації № 008/о ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
---	--

ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦІЇ № 383

Операція №

від 05.07.2023
(число, місяць, рік)

П.І.Б. хворого:	Свідерський Василь Петрович	Медична карта №: 3238
Хірург:	Літвинов І. О.	Асистент: Адамик П. М.
Анестезіолог:		
Діагноз до операції:	S86.0 - Травма п'яtkового [ахіллового] сухожилка* Травматичний розрив правого ахіллового сухожилля.	Інтерн:
Вид анестезії:	місцева.	Сестра медична операційна: Бандура О.
Діагноз після операції:	S86.0 Травма п'яtkового [ахіллового] сухожилка Травматичний розрив правого ахіллового сухожилля.	Сестра медична анестезист:

11. Контрольний список дій щодо безпеки в операційній

11.1. До початку анестезії (в присутності, щонайменше сестри медичної - анестезиста та анестезіолога)	11.2. До розрізу шкіри (в присутності хірурга, сестри медичної операційної, сестри медичної - анестезиста та анестезіолога)	11.3. До того як пацієнт покине операційну (в присутності хірурга, сестри медичної операційної, сестри медичної-анестезиста та анестезіолога)
11.1.1. Місце оперативного втручання марковане " так " не застосовується 11.1.2. Проведено перевірку обладнання та лікарських засобів для анестезії " так 11.1.3. Пульсоксиметр, капнограф, ЕКГ-електроди та манжетка тонометра та температурні датчики зафіксовані на пацієнті і правильно функціонують " так 11.1.4. Уточнено наявність у пацієнта: Алергії " так Складних дихальних шляхів або ризик аспірації " ні Ризику крововтрати більше 500 мл (більше 7 мл/кг у дітей) " ні	11.2.1. Всі члени операційної бригади представилися по імені і назвали свою роль 11.2.2. Підтверджено процедуру і місце, де буде проведено розріз 11.2.3. Проведено антимікробну профілактику за 60 хв (або за дві години, якщо використовувався ванкомицин) " так 11.2.4. Очікувані критичні події попередньо обговорено Зі сторони хірурга: " критичні або не рутинні події " тривалість операції " очікуваний об'єм крововтрати Зі сторони анестезіолога: " особливості, пов'язані з пацієнтом Зі сторони операційних медичних сестер: " стерильність підтверджена " відсутні проблеми із обладнанням або інші проблеми 11.2.5. Візуалізація необхідних зображень забезпечена " так	11.3.1. Хірург/сестра медична операційна: " уточнено назву проведеної процедури/операції " проведено підрахунок інструментів, тампонів, голів та інших медичних виробів " біологічні зразки марковано (зачитує написи на зразках включно із прізвищем пацієнта) " зафіксовано усно або письмово наявність проблем із обладнанням, що потребують усунення 11.3.2. Хірург та анестезіолог: " план післяопераційного ведення і реабілітації пацієнта погоджено Сестра медична-анестезист: (Прізвище, ім'я та підпис)

ОПИС ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ

Початок операції: 17:00 Кінець операції: 17:55 Тривалість операції: 55 хв.

Назва/Код операції 49718-01 - Відновлення Ахіллового сухожилля

Тип операції ургентна

Під місцевою анестезією, після обробки операційного поля проведений оперативний доступ до правого ахіллового сухожилля. При ревізії виявлено повний його розрив, пошкоджені частини сухожилля не спаяні з навколишніми тканинами. Края сухожилля рубцово змінені. Виконано освіження пошкоджених кінців сухожилля, малоінвазивно виконано шов останнього. Фіксація задовільна. Рана промита розчинами антисептиків. Пошарові шви. Ас пов'язка. Гіпсова пов'язка.

Опис препарату (видаленого органа, частини органа):

О.

Підпис хірурга: Літвинов І.

Загальний аналіз крові
05.07.2023

Показники	Одиниці	Результати	Норм. Показники
ШОЕ (SER):	мм/год	26	1-15
Гемоглобін(HGB):	г/л	175,00	119 - 154
Еритроцити (RBC):	10*12 клітин/л	6,13	4,18 - 5,48
Лейкоцити (WBC)-абс.:	10*9 клітин/л	6,9	3,91 - 8,77

Нейтрофіли -%:	%	69,500	40,3 - 74,8
Лімфоцити (LYM)-%	%	25,200	12,2 - 47,1
MXD - %:	%	5,300	4,4 - 12,3

ОБСТЕЖЕННЯ (RW/AIDS/Rg)

Обстеження на RW:	05.07.2023	4189	Негативний
	(число, місяць, рік)	(№ обстеження)	(результат)

54. Діагноз заключний клінічний

Назва діагнозу		Код за МКХ-10
Основний	Травма п'яtkового [ахіллового] сухожилка Травматичний розрив правого ахіллового сухожилка (з накладанням гіпсової пов'язки).	S86.0

Додаткові діагнози: ускладнення основного діагнозу - 1; супутнє захворювання - 2

55. МЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ:

- Оперативне лікування.
- В п/о періоді антибіотикопрофілактика, НПЗП, венотоніки, антикоагулянти, ІПП.

56. ЛІКУВАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РЕЖИМ ХВОРОГО:

- подальше спостереження у сімейного лікаря, травматолога (хірурга) в поліклініці за м/п,
- етапна зміна гіпсової пов'язки через 4 тижні після операції,
- іммобілізація правої н/кінцівки терміном до 6 тижні після операції,

Приймати:

- при болях диклотол по 1 табл. 2р/д
- нормовен по 1 т.2р/д 3 тижні після операції.
- рідексія (серрата) 10 мг по 1т 2р/д - 10 днів,
- ендоксакорд 60 мг по 1т 1р/д - 3 тижні після виписки.

57. РЕЗУЛЬТАТ МЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ:

виписаний(а) з: одужанням -1; поліпшенням -2; погіршенням -3; без змін -4; помер(ла) -5;

переведений(а) до іншого закладу охорони здоров'я -6; здоровий(а) -7

2

57.1. П.І.Б. лікаря Літвинов І. О. підпис _____ реєстраційний номер Litvynov

57.2. П.І.Б. зав. відділення Хоміцький І.М. підпис _____ реєстраційний номер KhomitskyiI

Дата заповнення **11.07.2023**
(число, місяць, рік)